EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90528
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 13-08-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: KAMILA IGNACIA SALDIAS SEPULVEDA			RUN	: 22.864.650-4
F.Nac	: 11-11-2008	Edad	: 15 AÑOS, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: EL SAUCE 840			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 74210930		
Fecha Ingreso	: 2024-08-08	Fecha Egreso	: 13-08-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G40-EPILEPSIA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Status convulsivo recuperado
- Sd Dravet/ mutación heterocigota SCN1A
- Epilepsia no refractaria secundaria
- DI leve-moderado
2. Neumonía basal derecha en tratamiento 5/7

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R56.8-OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J20-J22-OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 15 años, con antecedentes de síndrome Dravet (genopatía SCN1A) en control por neurología infantil (Dra. Schmidt) y tratamiento con topiramato 75 mg c/12 hrs+ LVT 1,5 gr c/12 hrs, , FUC 06/07/24 (en relación a menstruación), quien es traída a urgencias por familiares por presentar episodio convulsivo tónico clónico generalizado sin recuperación del estado de conciencia con duración mayor a 30min. Al interrogatorio dirigido refieren 5 días de evolución con CEG y tos productiva.
Ingresa a urgencias en estado post ictal y se presencia nuevo episodio convulsivo con duración de 7 min que no respondió a BZP ameritando propofol 20mg y carga con levetiracetam 2 gr. En mala s condiciones mal perfundida, febril sin recuperación de estado de conciencia por lo que se realiza ISR y se conecta a VMI. En exámenes de ingreso destaca Creat 0.6 PCR 5.0 tes rápido de influenza y covid (-) leucocitosis 23.200 y acidosis respiratoria severa con pH 6.77 pCO2 102, tac de cerebro sin lesiones agudas, tac de tórax con foco de consolidación basal derecho. Se ingresa a UCI para manejo, evolucionando de forma favorable, con corrección progresiva de trastornos infecto - metabólicos, sin requerimientos de O2 adicional, sin nuevas crisis.
Actualmente en sala, en buen estado general, deambulando sin apoyo, buena tolerancia a ingesta oral, tranquila, sin deterioro neurológico respecto a su basal. Se conversa con su madre, por estabilidad clínica cursando 5/7 ATB (ceftriaxona 2 gr ev dia) indico HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. HOSPITALIZACION DOMICILIARIA
2. REPOSO RELATIVO
3. REGIMEN LIVIANO
4. LEVETIRACETAM JARAB 100 MG/ML 20 ML VO C/12 HRS

5. TOPIRAMATO 25 MG 3-0-3 VO
6. CEFTRIAXONA 2 GR EV DIA (HOY 5/7)
7. PARACETAMOL 1 GR VO SI DOLOR O FIEBRE
8. BROMURO IPRATROPIO 2 PUFF C/8 HRS + AEROCAMARA X 5 DÍAS
9. CONTROL POLICLINICO NEUROLOGIA 2 SEMANAS POST ALTA
10. EN CASO DE NUEVAS CRISIS > 5 MIN O MAS DE 1 SIN RECUPERACION DE CONCIENCIA-> ACUDIR A URGENCIAS

EXÁMENES Y RESULTADOS

12.08.24: PCR 13,8, crea 0,5, P. hepaticas N, ck 62, lactato 0,6, uremia 13, bun 28, na+ 143, k+ 3,4, Cl 111, hto 32,8%, leucocitos 6800, plaquetas 231.000
PANEL VIRAL negativo
procalcitonina 6,3 (en descenso)
CSB aun pendiente resultado

Control en: 14 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ LAGOS
MEDICO TRATANTE
15877858-0

JEFE SERVICIO